



PATOLOGIAS DO COLO UTERINO

CLAUDIA FONTENELLE

GINECOLOGISTA E OBSTETRA

ESPECIALISTA EM SEXUALIDADE HUMANA

PRECEPTORA UNINOVAFAP

PÓLIPOS CERVICAIS



-Pólipos endocervicais, também chamados de pólipos cervicais, são aqueles que se desenvolvem no colo do útero.

-Crescimento desordenado de tecidos comuns e também são, na imensa maioria dos casos, lesões benignas.

Grande parte dos pólipos endocervicais também não apresentam sintomas.

Quando há manifestações sintomáticas:

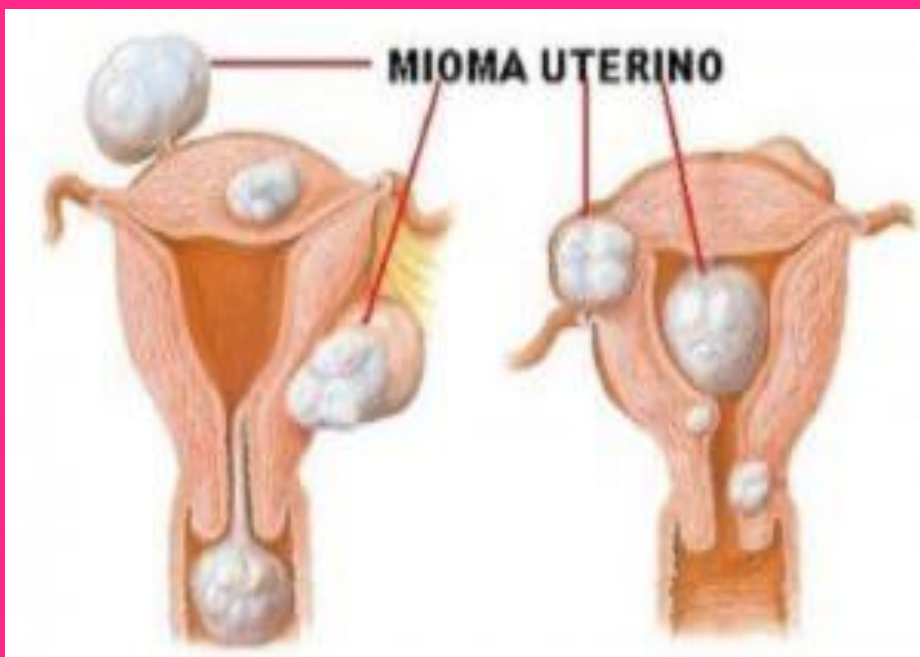
Sangramento entre os ciclos menstruais;
(SUA)

Secreção vaginal purulenta (casos raros);

Sangramento após as relações sexuais.

(SINUSORRAGIA)

LEIOMIOMA UTERINO



Nodularidade uterina benigna

Tumores sólidos formados principalmente por músculo liso, ocorrendo em 20% a 40% das mulheres em idade fértil

Causa mais comum de aumento de volume uterino não grávido

Quinta causa principal causa de internações hospitalares por doenças ginecológicas, não relacionadas à gravidez, em mulheres com idade de 15 a 44 anos

Dor pelvica importante e sangramento uterino anormal

`Mioma parido`

Riscos: aborto, parto prematuro (15% a 20%), crescimento intrauterino restrito (10%) e apresentação fetal anômala (20%), DPP - Placenta, torção de mioma.

ENDOMETRIOSE CERVICAL

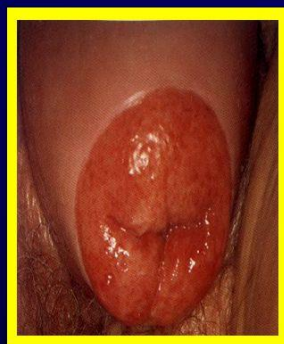
❖5- OUTRAS



ENDOMETRIOSE



COLPITE ATRÓFICA



ÚLCERA EM PROLAPSO

Doença inflamatória de causa desconhecida, caracterizada pela presença de glândulas e estromas endometriais fora da cavidade uterina, principalmente na região pélvica.

- Acomete mulheres no período reprodutivo
- 10% das mulheres no período reprodutivo, ou seja, aproximadamente 100 milhões de mulheres em todo o mundo
- Sinais e sintomas da doença observados na história clínica e no exame físico – dismenorreia é o principal sintoma.

Dispareunia

DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA (DIP)

DIP

Atenção à epidemiologia

↓

Diagnóstico



• dados clínicos: muco cervical (aspecto mucopurulento) ou sinais de cervicite

- Síndrome aguda decorrente da ascensão de micro-organismos do trato genital inferior comprometendo endométrio, anexos uterinos e ou outras estruturas.
- Agentes patogênicos do trato genital inferior ascendem pelo colo uterino, levando a endometrite, salpingite e peritonite.
- Infecções frequentemente polimicrobianas, com envolvimento de bactérias anaeróbias e facultativas, sendo 90% originárias de agentes sexualmente transmissíveis.
- *Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis*
- *Gardnerella vaginalis*, *Mycoplasma hominis*, *Ureaplasma urealyticum*, *Streptococcus*, beta-hemolítico do grupo A, anaeróbios
- PRINCIPAIS SINTOMAS: Dor no abdome inferior • Dor à palpação de regiões anexiais • Dor à mobilização do colo uterino
- Conteúdo vaginal ou secreção cervical anormal (purulento), colo friável, dispareunia, sinusorragia, sangramento urerino anormal, febre.

ECTOPIA

3-EXAME DO COLO UTERINO

COLPOSCOPIA:
ACHADOS NORMAIS

ECTOPIA



Ectopia Cervical é um fenômeno fisiológico, ou seja, **NORMAL** e pode aparecer em algum momento na vida da mulher.

Aparecimento das células glandulares no colo do útero

A ectopia adquirida divide-se em hormonal, traumática e inflamatória.

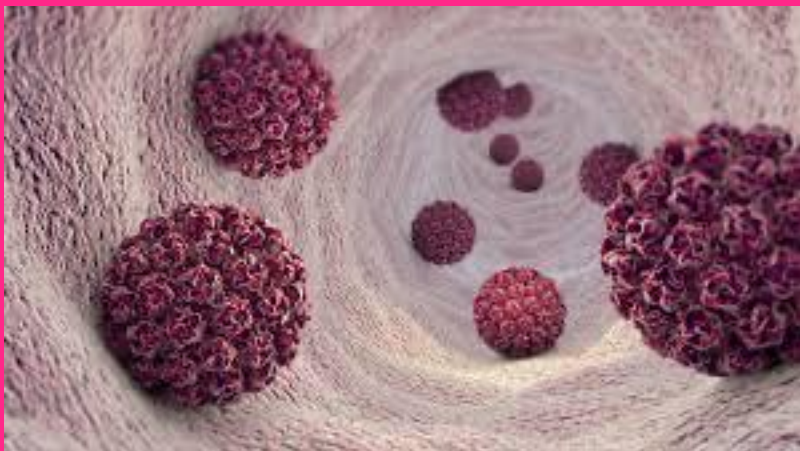
A hormonal é a mais comum e pode ocorrer na adolescência, na gestação e devido ao uso de medicação estrogênica (como os **anticoncepcionais hormonais combinados** e a **terapia de reposição hormonal**).

A traumática pode ser observada em decorrência da laceração do colo no momento do parto e a inflamatória em função de cervicites (inflamações no colo do útero).

Erroneamente chamada de FERIDA NO COLO UTERINO

Tratar **apenas se sintomática**

HPV (PAPILOMA VÍRUS HUMANO)



O HPV (sigla em inglês para **Papilomavírus Humano**) é um vírus que infecta pele ou mucosas (oral, genital ou anal), tanto de homens quanto de mulheres, provocando verrugas anogenitais (região genital e no ânus) e câncer, a depender do tipo de vírus.

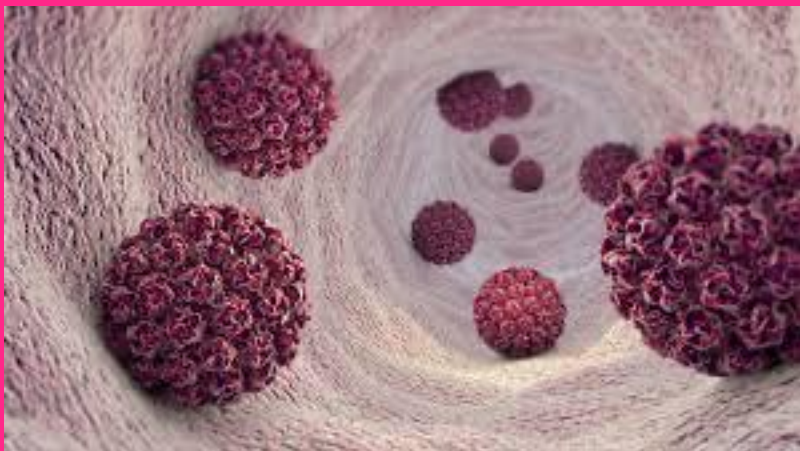
A infecção pelo HPV é uma **Infecção Sexualmente Transmissível (IST)**.

Mais de 200 subtipos estudados (oncogênicos e não oncogênicos)

A infecção pelo HPV **não apresenta sintomas na maioria das pessoas**.

Em alguns casos, o HPV pode ficar latente de meses a anos, sem manifestar sinais (visíveis a olho nu), ou apresentar manifestações subclínicas (não visíveis a olho nu).

HPV (PAPILOMA VÍRUS HUMANO)



Diminuição da resistência/imunidade do organismo pode desencadear a multiplicação do HPV e, conseqüentemente, provocar o aparecimento de lesões.

A maioria das infecções em mulheres (sobretudo em adolescentes) **tem resolução espontânea, pelo próprio organismo, em um período aproximado de até 24 meses.**

As primeiras manifestações da infecção pelo HPV surgem entre, aproximadamente, 2 a 8 meses, mas pode demorar até 20 anos para aparecer algum sinal da infecção.

As manifestações costumam ser mais comuns em gestantes e em pessoas imunossuprimidas.

O diagnóstico do HPV é atualmente realizado por meio de exames clínicos e laboratoriais, dependendo do tipo de lesão, se clínica ou subclínica.



HPV (PAPILOMA VÍRUS HUMANO)



Lesões clínicas: se apresentam como verrugas na região genital e no ânus (denominadas tecnicamente de condilomas acuminados e popularmente conhecidas como "crista de galo", "figueira" ou "cavalo de crista").

Podem ser únicas ou múltiplas, de tamanhos variáveis, achatadas ou papulosas (elevadas e solidas). Em geral, são assintomáticas, mas podem causar coceira no local. Essas verrugas, geralmente, são causadas por tipos de HPV não cancerígenos.

Lesões subclínicas (não visíveis ao olho nu): podem ser encontradas nos mesmos locais das lesões clínicas e não apresentam sinal/sintoma.

As lesões subclínicas podem ser causadas por tipos de HPV de baixo e de alto risco para desenvolver câncer.

Podem acometer vulva, vagina, colo do útero, região perianal, ânus, pênis (geralmente na glândula), bolsa escrotal e/ou região pubiana.

Menos frequentemente, podem estar presentes em áreas extragenitais, como conjuntivas, mucosa nasal, oral e laringea.

Mais raramente :crianças que foram infectadas no momento do parto podem desenvolver lesões verrucosas nas cordas vocais e laringe (Papilomatose Respiratória Recorrente).



PREVENÇÃO



PREVENÇÃO

Vacinar-se contra o HPV é a medida mais eficaz de se prevenir contra a infecção. A vacina é distribuída gratuitamente pelo SUS e é indicada para:

Meninas e meninos de 9 a 14 anos, com esquema de 2 doses.

Adolescentes que receberem a primeira dose dessa vacina nessas idades , poderão tomar a segunda dose mesmo se ultrapassado os seis meses do intervalo preconizado, para não perder a chance de completar o seu esquema;

Mulheres e Homens HIV+, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, com esquema de três doses (0,2,6 meses) , independentemente da idade;

A vacina não previne infecções por todos os tipos de HPV, mas é dirigida para os tipos mais frequentes: 6, 11, 16 e 18 (SUS).

Exame preventivo contra o HPV, o Papanicolau é um exame ginecológico preventivo mais comum para identificar de lesões precursoras do câncer do colo do útero.

Ajuda a detectar células anormais no revestimento do colo do útero, que podem ser tratadas antes de se tornarem câncer.

Fatores de Risco de CA de Colo de Útero

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Vírus HPV• Outras IST's• Imunidade Comprometida• Deficiência de Alfa-1-Antitripsina (Única influência genética, rara e mais comum em Afrodescendentes)• Exposição a Radiação Ionizante• Exposição a agente químicos | <ul style="list-style-type: none">• Múltiplos parceiros sexuais• Tabagismo• Higiene Genital Inadequada• Deficiência Vitamínica• Desnutrição• Multiparidade• Baixo nível socioeconômico• Parceiros(as) sexuais com fatores de risco |
|--|---|

Vírus HPV

Vírus HPV					
Classificação de acordo com risco oncológico	Alto Risco	16 → Mais prevalente, mais comum em carcinomas escamosos		47% Apresenta Neoplasia Intraepitelia Cervical 47,1% Avança para CA invasivo	
		18 → Mais comum em adenocarcinomas			
	Médio Risco				
	Baixo Risco	6 e 11 → Lesões Genitais		Não avançam para CA invasivo	
Apresentação	Latente	Sem lesão			
	Subclínica	Lesão percebida apenas em citologia ou colposcopia			
	Clínica	Lesão Importante, Condilomas, Neoplasias...			
Prevenção	CoMportamental	Intervir em hábitos de higiene genital, alimentação, número de parceiros, saúde do(a) parceiro(a), Cessar tabagismo, tratar deficiências de imunidade e comorbidades			
	Vacinação	Bivalente	9-14 anos: 2 doses (0 – 5 a 13meses)		Para pacientes com deficiência imunológica não há limite de idade
			15-26 anos: 3 doses (0 – 1meses – 6meses)		
		Quadrivalente	9-13 anos: 2 doses (0 – 6meses)		
			14-26 anos: 3 doses (0 – 2meses – 6meses)		
		Nonavalente	3 doses (0 – 2meses – 6meses)		



HPV NONAVALENTE

Gardasil MSD

GARDASIL® 9 contém os mesmos 4 tipos de HPV (6, 11, 16 e 18) que GARDASIL® com mais 5 outros tipos de HPV (31, 33, 45, 52 e 58).

► Meninas e mulheres entre 9 e 26 anos de idade e meninos e homens entre 9 e 45 anos de idade podem receber GARDASIL® 9.

Primeira dose: na data escolhida por você e seu médico;

- Segunda dose: 2 meses após a primeira dose (não antes que 1 mês após a primeira dose);

- Terceira dose: 6 meses após a primeira dose (não antes que 3 meses após a segunda dose).



minsaude



NOVIDADE

Vacina HPV agora
em **dose única**
no Calendário
Nacional de
Vacinação



**PESSOAS DE 09 A
14 ANOS DE IDADE
DEVEM SE VACINAR,
INDEPENDENTEMENTE
DO SEXO.**



BRASIL BEM
CUIDADO
Muito mais para quem não para



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Diretriz	Ministério da Saúde	ACS (American Cancer Society)	ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists)
Início do Rastreamento	25 anos (Se já sexualmente ativa)	21 anos - Ou 3 anos após a primeira relação sexual vaginal	21 anos - Ou 3 anos após a primeira relação sexual vaginal
Intervalo	- Dois primeiros anos: 1 ano - Após dois negativos consecutivos: 3 anos	- Para Citologia convencional: Anual - Para Citologia em meio líquido: 2 anos - Após os 30 anos, se três exames normais consecutivos: 2-3 anos	- Para Citologia convencional ou em meio líquido: Anual - Após os 30 anos, se três exames normais consecutivos: 2-3 anos
Interromper	Após os 64 (Se houver pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos)	70 anos (Se houver três exames normais consecutivos em dez anos) - Ou Em Qualquer idade Após histerectomia por doença benigna	Não há limite máximo de idade

Casos Especiais	Conduta
Mulheres Virgens	Não realizar rastreamento
Primeiro exame for realizado após os 64 anos	2 Com intervalo de 1-5 meses e só se ambas forem negativas deve-se interromper o rastreamento
Histerectomia prévia por causa benigna	- Exames Anteriores Normais → Interromper Rastreamento - Lesão Precussora de CA de Colo de Útero → Rastreamento conforme lesão tratada
Mulheres Imunossuprimidas	- CO a cada 2 meses. - Após duas CO normais, realizar anualmente até que a paciente não esteja mais imunossuprimida.

Rastreamento e Diagnóstico de Lesão Intraepitelial Cervical

Tripé Clássico:

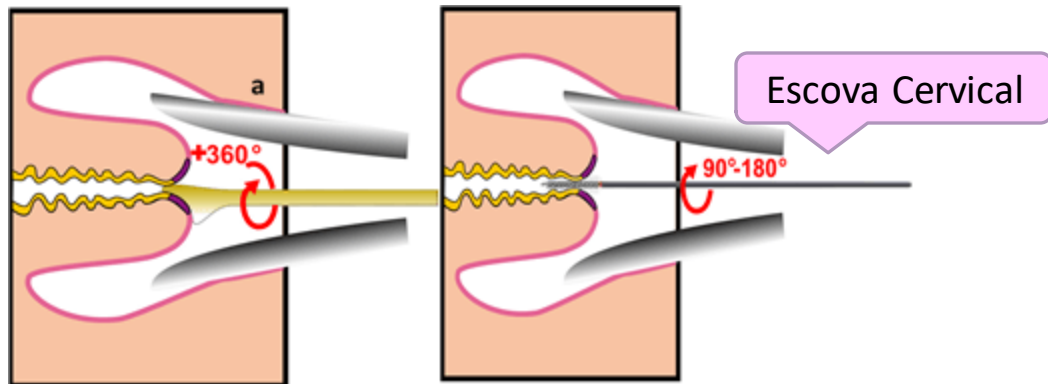
- Citologia CervicoVaginal
- Colposcopia (biópsia dirigida - lesão)
- Histopatologia

+ Testes moleculares de detecção de DNA-HPV:

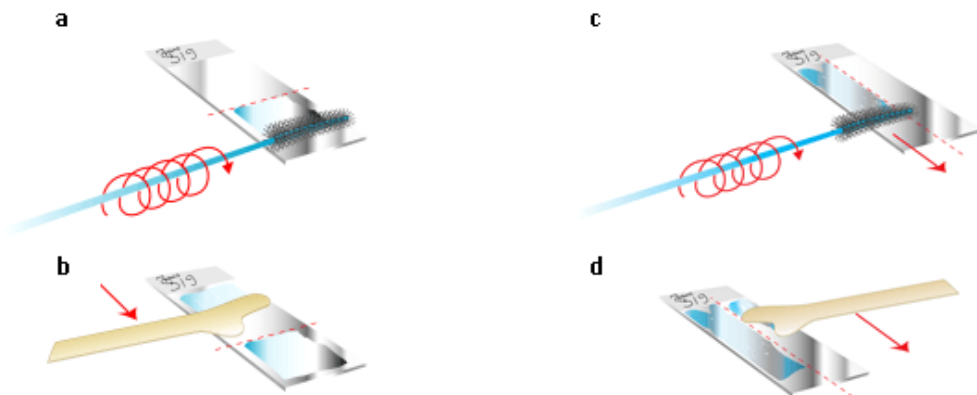
- Captura Híbrida
- PCR

Etapas de descrição*	Características	
Avaliação geral	Colposcopia adequada ou inadequada (especificar o motivo sangramento, inflamação, cicatriz etc.) Visibilidade da junção escamocolunar: completamente visível, parcialmente visível e não visível Zona de transformação Tipo 1, 2 ou 3	
Achados colposcópicos normais	Epitélio escamoso original (maduro ou atrófico) Epitélio colunar (inclusive ectopia) Epitélio escamoso metaplásico: com cistos de Naboth e/ou orifícios (glandulares) abertos Decidua na gravidez	
Achados colposcópicos anormais	Princípios gerais	Localização da lesão: dentro ou fora da ZT e de acordo com a posição do relógio Tamanho da lesão: número de quadrantes do colo uterino envolvidos pela lesão e tamanho da lesão em porcentagem do colo uterino
	Grau 1 (menor)	Epitélio acetobranco tênue, de borda irregular ou geográfica, mosaico fino ou pontilhado fino
	Grau 2 (maior)	Epitélio acetobranco denso, acetobranqueamento de aparecimento rápido, orifícios glandulares espessados, mosaico grosseiro, pontilhado grosseiro, margem demarcada, sinal da margem interna, sinal da crista (sobrelevação)
	Não específicos	Leucoplasia (queratose, hiperqueratose), erosão, captação da solução de lugol: positiva (corado) ou negativa (não corado) (teste de Schiller negativo ou positivo)
Suspeita de invasão	Vasos atípicos Sinais adicionais: vasos frágeis, superfície irregular, lesão exofítica, necrose, ulceração (necrótica), neoplasia tumoral/grosseira	
Miscelânea	Zona de transformação congênita, condiloma, pólipos (ectocervical/endocervical), inflamação, estenose, anomalia congênita, seqüela pós-tratamento, endometriose	

Espátula de Ayres



Escova Cervical



JEC – Junção escamocolunar
Endocérvice – Epitélio Colunar Simples
Ectocérvice – Epitélio Escamoso/Pavimentoso

Exame Citopatológico

- **Adequabilidade da amostra**

Amostra Insatisfatória:

Hipocelular (<10% do esfregaço)

Leitura prejudicada (>75% do esfregaço com superposição)

Coletar nova amostra – em 6 a 12 meses ou em rastreamento oportunista.

- **Células representativas do Epitélio**

Cel. Escamosas e Colunares

Cel. Metaplasicas

Cel. Glandulares (não inclui o epitélio endometrial).

- **Achados Microbiológicos**

Bacilos – Microbiota (DD Infecção - Sintomas)

- **Achados de Metaplasia Imatura**

Benignas

Continuar com rotina de rastreamento normal

- **Exame Normal**

Negativo para neoplasias

Negativo para malignidade

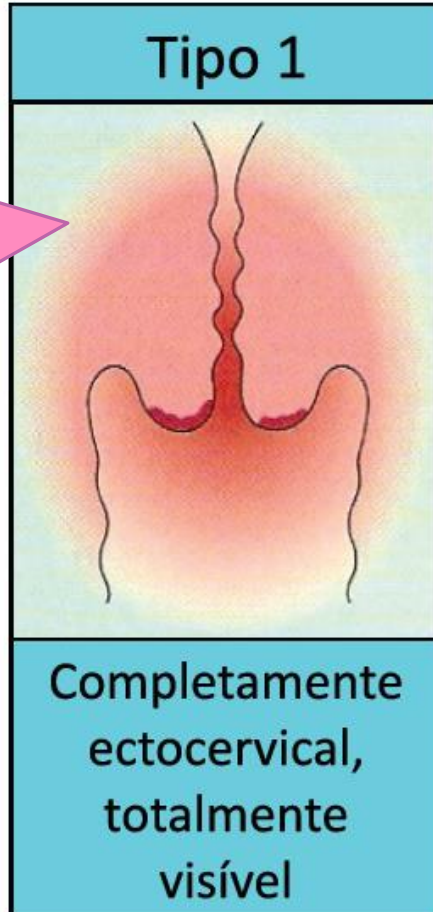
Dentro dos limites de normalidade citados

Tipos de Zona de Transição (metaplasia escamosa)

Tratamento Cirúrgico com Excisão da Zona de Transição

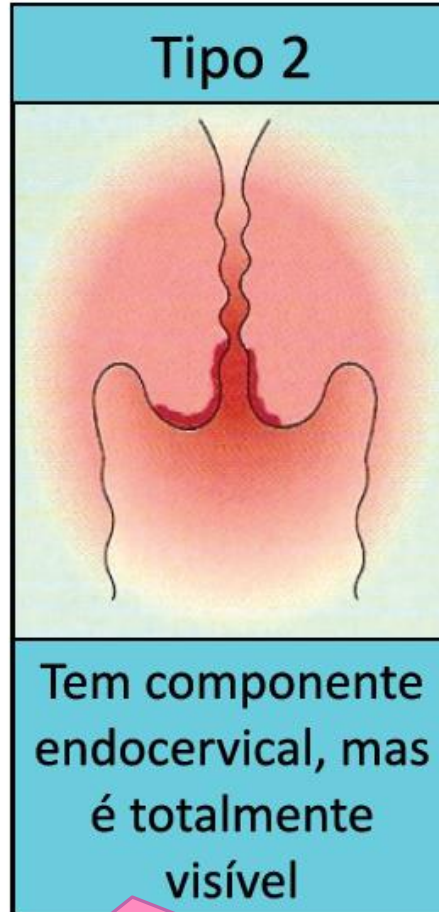
Excisão tipo 1:

Tratar a doença ectocervical ou que não se estende mais de 1 cm no canal endocervical



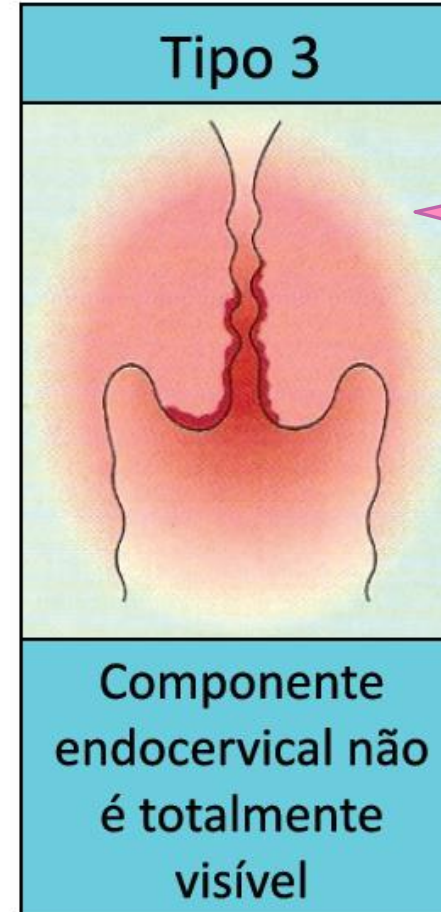
Tipo 2

Excisão tipo 2: retirar maior porção do canal endocervical, ultrapassar a JEC, o que costuma chegar a profundidade de 1,5 e 2,0 cm



Tipo 3

Excisão tipo 3: Retirar entre 2 e 2,5 cm de canal. Aplicável na maioria das NIC III.



Quadro 3 – Nomenclatura citopatológica e histopatológica utilizada desde o início do uso do exame citopatológico para o diagnóstico das lesões cervicais e suas equivalências

Classificação citológica de Papanicolaou (1941)	Classificação histológica da OMS (1952)	Classificação histológica de Richart (1967)	Sistema Bethesda (2001)	Classificação Citológica Brasileira (2006)
Classe I	-	-	-	-
Classe II	-	-	Alterações benignas	Alterações benignas
-	-	-	Atipias de significado indeterminado	Atipias de significado indeterminado
Classe III	Displasia leve	NIC I	LSIL	LSIL
	Displasia moderada e acentuada	NIC II e NICIII	HSIL	HSIL
Classe IV	Carcinoma <i>in situ</i>	NIC III	HSIL Adenocarcinoma <i>in situ</i> (AIS)	HSIL AIS
Classe V	Carcinoma invasor	Carcinoma invasor	Carcinoma invasor	Carcinoma invasor

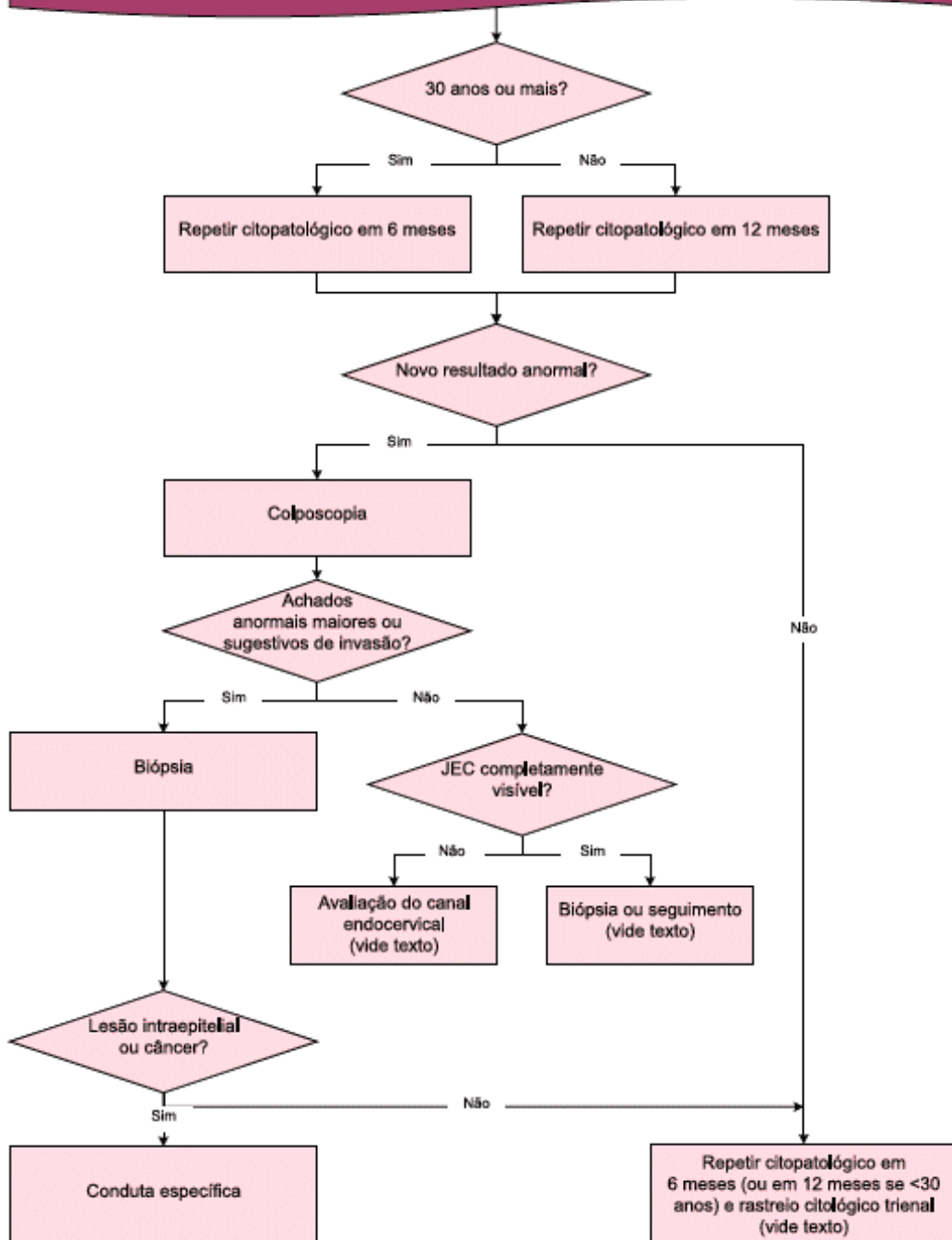
Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau

Lesão intraepitelial escamosa de alto grau

Quadro 4 – Resumo de recomendações para conduta inicial frente aos resultados alterados de exames citopatológicos nas unidades de atenção básica

Diagnóstico citopatológico		Faixa etária	Conduta inicial
Células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASCUS)	Possivelmente não neoplásicas (ASC-US)	< 25 anos	Repetir em 3 anos
		Entre 25 e 29 anos	Repetir a citologia em 12 meses
		≥ 30 anos	Repetir a citologia em 6 meses
	Não se podendo afastar lesão de alto grau (ASC-H)		Encaminhar para colposcopia
Células glandulares atípicas de significado indeterminado (AGC)	Possivelmente não neoplásicas ou não se podendo afastar lesão de alto grau		Encaminhar para colposcopia
Células atípicas de origem indefinida (AOI)	Possivelmente não neoplásicas ou não se podendo afastar lesão de alto grau		Encaminhar para colposcopia
Lesão de Baixo Grau (LSIL)		< 25 anos	Repetir em 3 anos
		≥ 25 anos	Repetir a citologia em 6 meses
Lesão de Alto Grau (HSIL)			Encaminhar para colposcopia
Lesão intraepitelial de alto grau não podendo excluir microinvasão			Encaminhar para colposcopia
Carcinoma escamoso invasor			Encaminhar para colposcopia
Adenocarcinoma <i>in situ</i> (AIS) ou invasor			Encaminhar para colposcopia

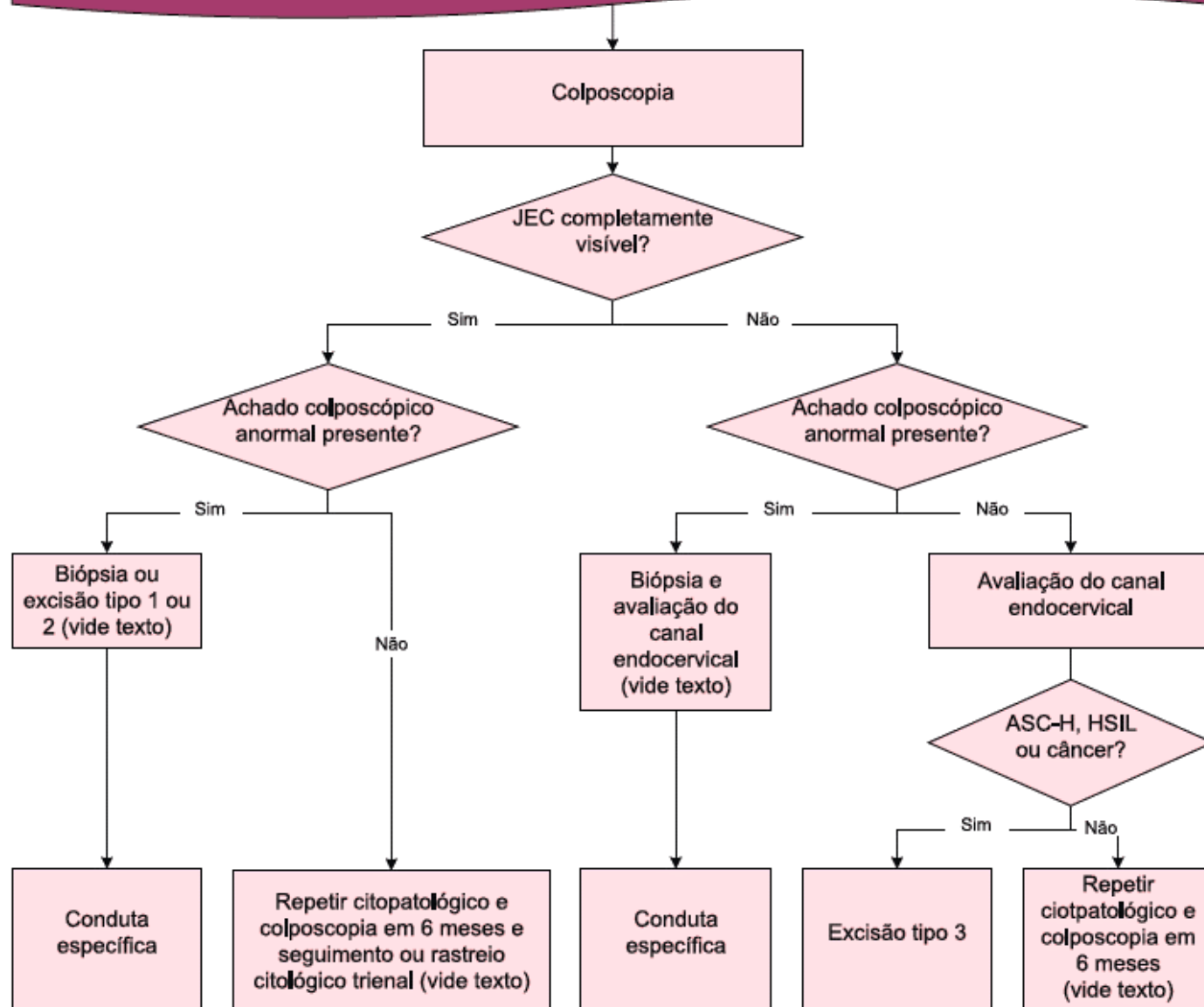
Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas (ASC-US)



Casos Especiais	Conduta
< 25 anos	CO em 3 anos • Normal: cessar rastreamento até os 25 anos • Mesmo resultado:, manter CO trienal • Piora, mas ainda em ASC-US ou mais grave: Encaminhas para Colposcopia aos 25 anos
Gestantes	Conduta Padrão
Imunossuprimidas	Encaminhamento Imediato para Colposcopia
Pós-Menopausa*	Realizar estrogênio terapia antes de CO ou Colposcopia

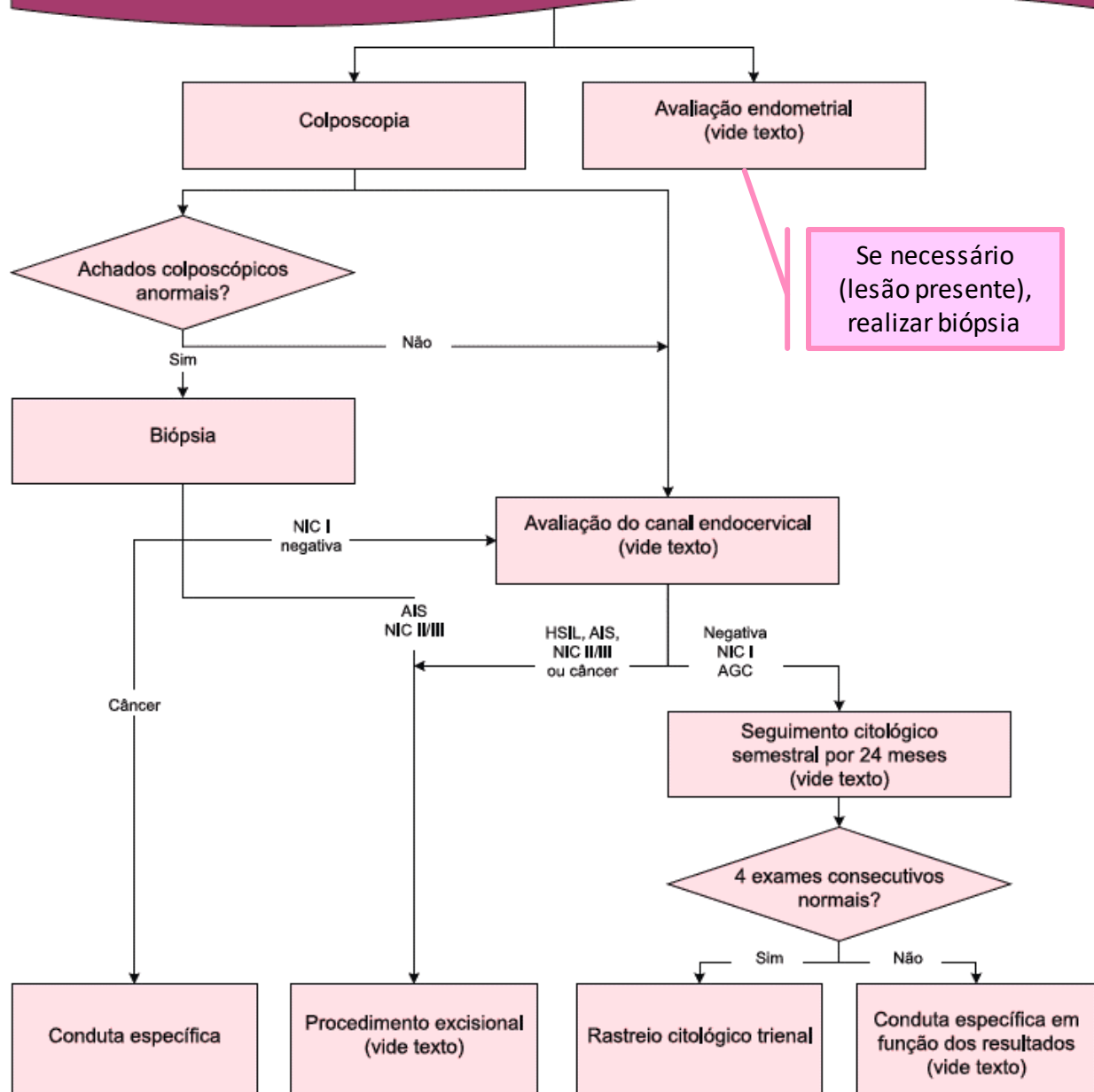
*Em razão da deficiência de estrogênio, apresentam alterações celulares no colo uterino e vagina, podendo acarretar resultados falso-positivos da citologia. Além disso, o exame citopatológico pode ter pior desempenho diagnóstico nesse grupo devido à atrofia, o que resulta em diminuição do número de células ectocervicais e endocervicais disponíveis para a amostragem.

**Células escamosas atípicas de significado indeterminado,
quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau (ASC-H)**



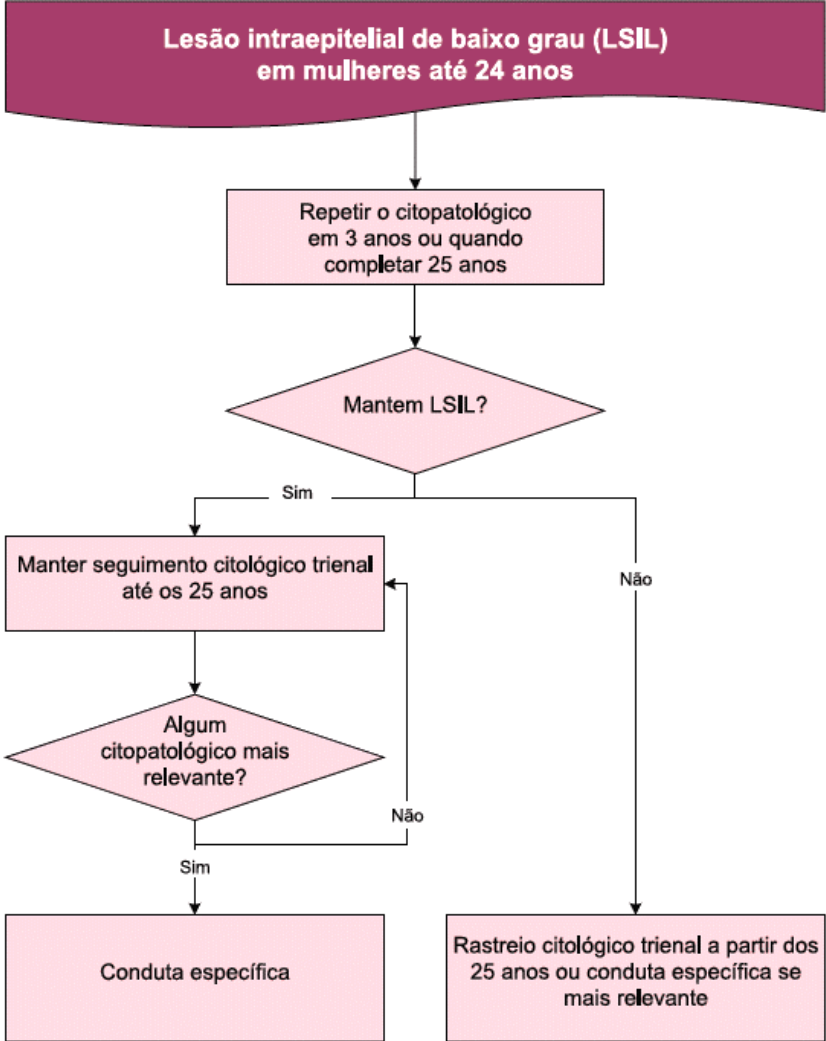
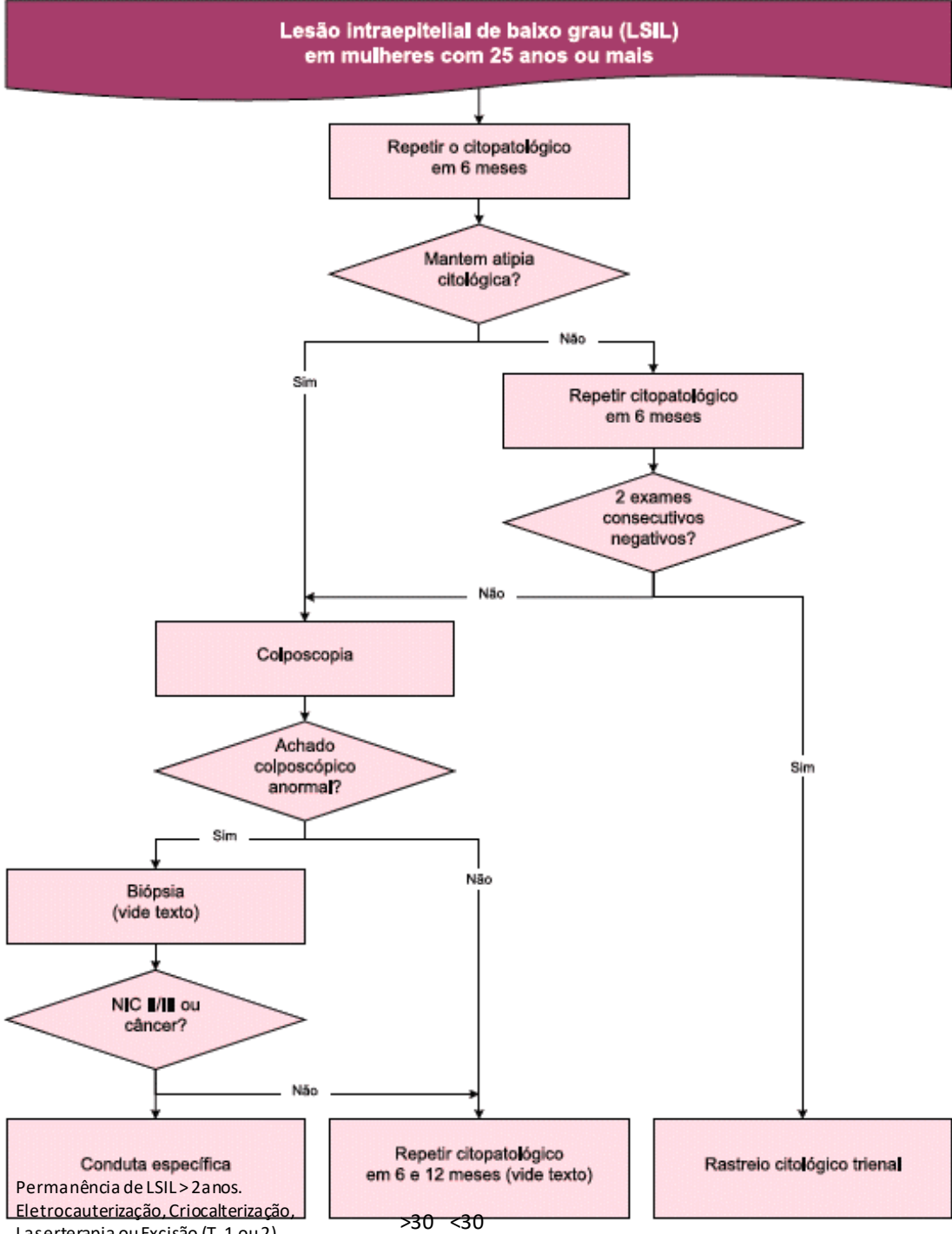
Casos Especiais	Conduta
< 25 anos	Encaminhamento Imediato para Colposcopia
Gestantes	
Imunossuprimidas	
Pós-Menopausa	Realizar estrogênio terapia antes de CO ou Colposcopia

Células glandulares atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas (AGC-US) ou em que não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau (AGC-H)



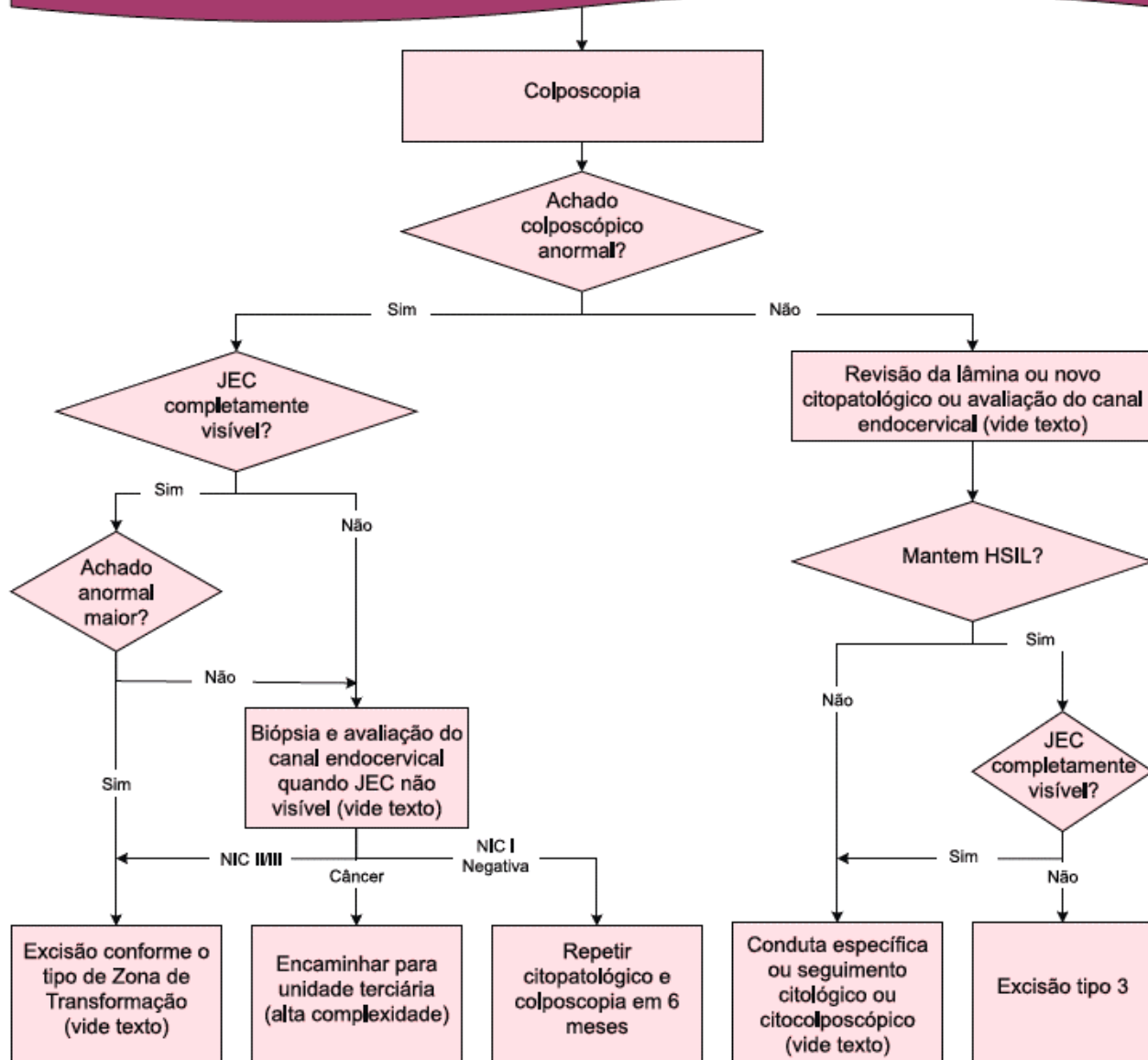
Casos Especiais	Conduta
Gestantes	Realizar apenas Colposcopia e dispensar a avaliação endometrial

Obs.: Atipias celulares glandulares podem estar relacionadas a metaplasia endometrial e ao câncer de endométrio.



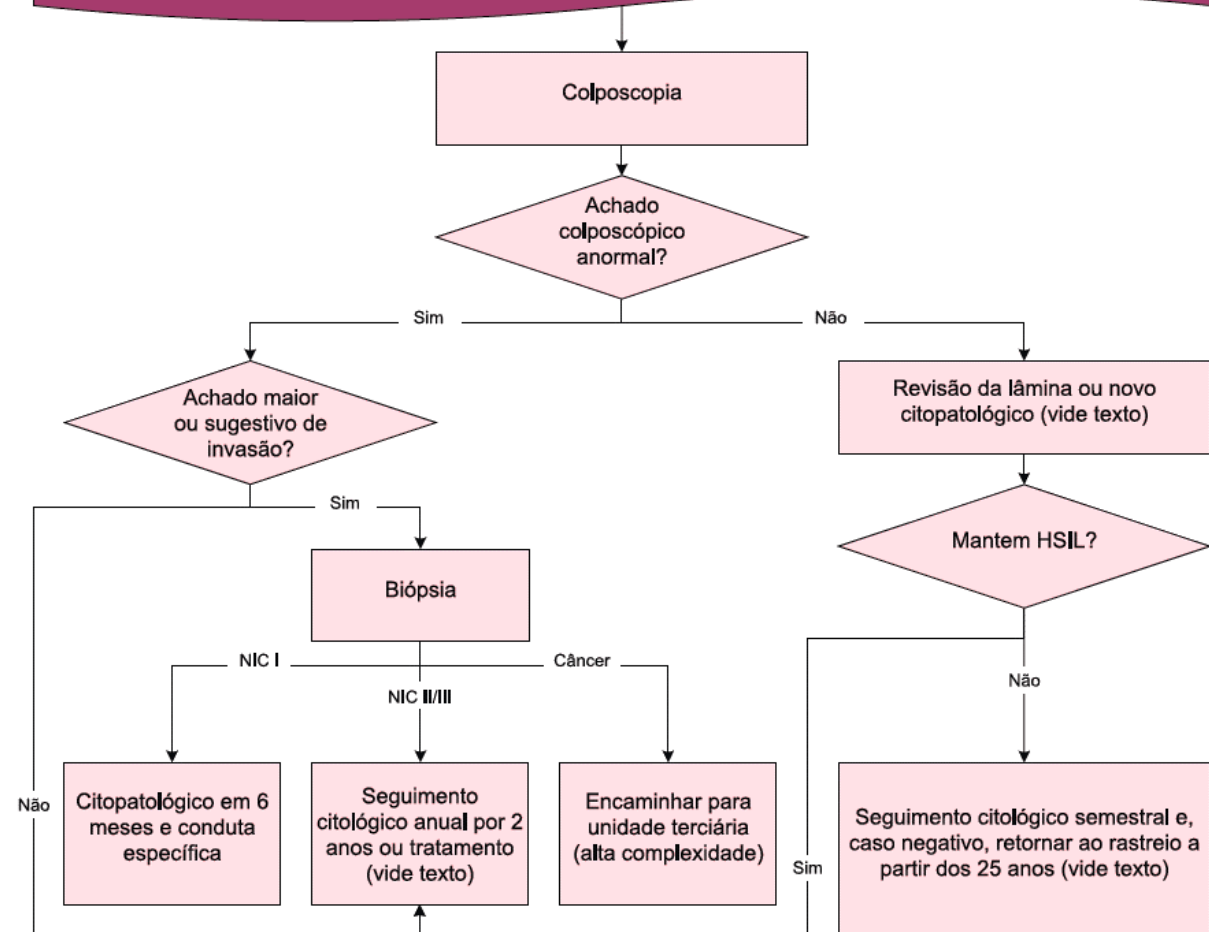
Casos Especiais	Condução
Gestantes	Realizar avaliação pós-parto
Imunossuprimidas	Encaminhamento Imediato para Colposcopia
Pós-Menopausa	Realizar estrogênio terapia antes de CO ou Colposcopia

Lesão intraepitelial de alto grau (HSIL) em mulheres com 25 anos ou mais



24 meses

Lesão intraepitelial de alto grau (HSIL) em mulheres até 24 anos



Acompanhamento pós-excisão

Excisão com margens livres

- CO 6/6 meses por 1 ano
- Colposcopia a critério
- Após 1 ano, CO anual até 5 anos desde o tratamento

Excisão com margens comprometidas

- CO e Colposcopia 6/6 meses por 2 anos
- Após 2 anos, CO anual até 5 anos desde o tratamento

Boas práticas recomendadas:

- Aconselhar e orientar previamente ao teste e ao resultado através de materiais informativos e de comunicação (folders, vídeos, encontros em grupos)
- Oferecer informações corretas e exaustivas sobre a infecção pelo HPV e seu significado psicosssexual, incluindo dados epidemiológicos e estatísticas para fácil compreensão
- Recomendar que a paciente evite pesquisas gerais na Internet em fontes não confiáveis. Estudos mostram que a experiência de pesquisar na Internet por informações sobre o HPV provoca ansiedade, medo e contribui para o estigma

GINECOACADEMY

- Evitar a “catastrofização” da notícia do HPV e normalizar a infecção, limitando as potenciais consequências negativas, sem menosprezar a relevância do vírus. Reforçar a importância da investigação, seguimento e rastreamento sistemático.
- Oferecer aconselhamento psicosssexual e informativo para a paciente e parceria(s), considerando problemas conjugais e psicológicos prévios e avaliação especializada, se necessário
- Reforçar acompanhamento adequado pode reduzir os sentimentos negativos e a ansiedade vivenciados pelas pessoas com HPV

GINECOACADEMY

**A DETECÇÃO DO HPV OU DE
LESÕES CAUSADAS PELO HPV
NÃO DEVE SER MOTIVO PARA >>>**



1

Vergonha ou indignação

2

Sentimento de "sujeira ou contaminação"

3

Restrição de espontaneidade ou investidas sexuais

4

Abstenção da prática sexual (vaginal, oral ou anal)

< 5

Sentimentos negativos contra a parceria atual >

- Afastamento, rompimento, perda confiança, agressividade ou violência
- Preocupação / medo de ser acusada de infidelidade ou do parceiro ter sido infiel

6

Confronto com parceria(s) prévia(s)

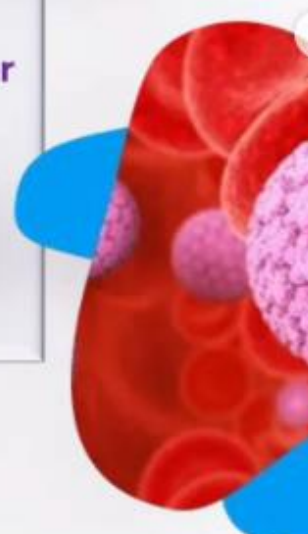
Outros: Medo em iniciar relacionamentos por receio de infectar ou ser reinfectada; dúvidas sobre o impacto na fertilidade.

Esclarecendo incertezas adicionais:

Descobrir que você tem HPV não significa que você ou seu parceiro foram ou estão sendo infiéis, mesmo que sejam parceiros únicos há muito tempo (monogamia).

- Muitas pessoas têm HPV há muito tempo sem nunca saber disso. Em alguns casos, o HPV pode permanecer no corpo por 10 a 30 anos.
- Além disso, o vírus pode reaparecer 40-50 anos após a infecção inicial devido ao declínio imunológico relacionado à idade.

GINECOACADEMY

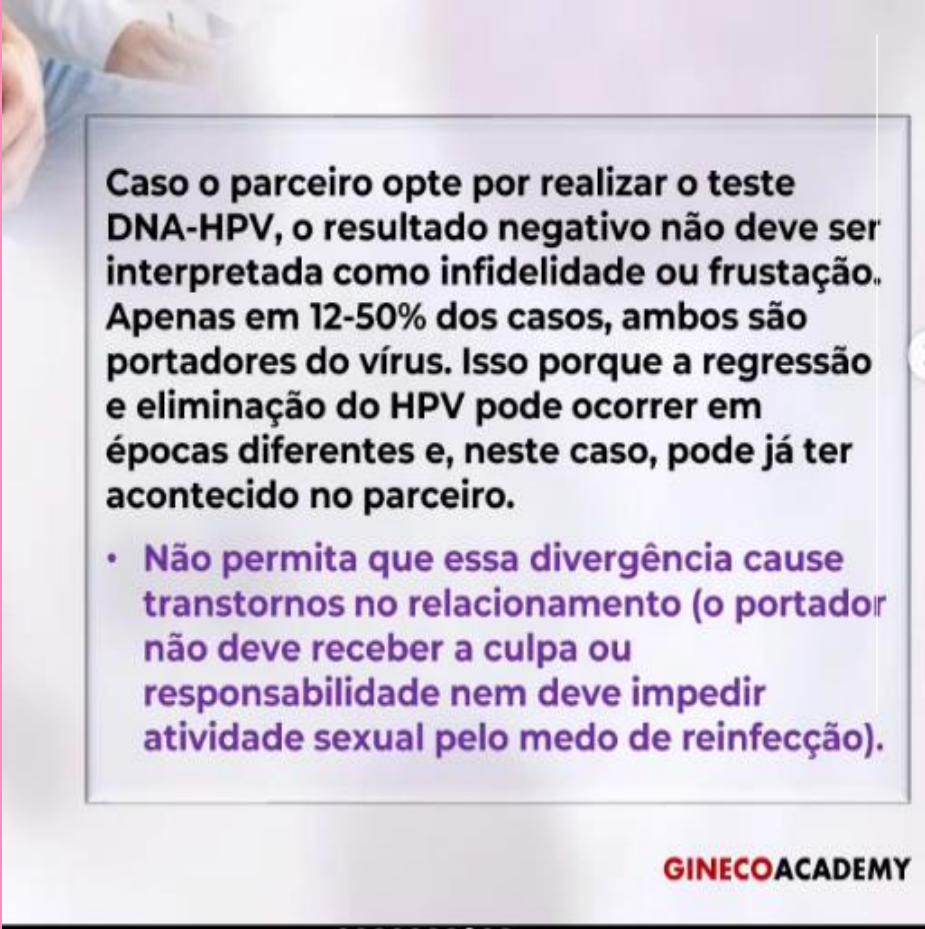


Parceiros masculinos não necessitam de avaliação genital urológica de rotina em caso de parceiras com teste DNA-HPV positivo, exceto se houver alterações clinicamente visíveis na região genital ou orofaringe (ex. verrugas).

- Além disso, é importante deixar claro que a avaliação e tratamento do parceiro não interferem na evolução ou recorrência de infecção da paciente e o risco de lesões neoplásicas em homens é 20 menor do que para mulheres.

Se você está com resultado atual positivo e já teve resultados negativos prévios não significa necessariamente que você foi infectada neste intervalo (ou que alguém tenha sido infiel caso esteja com a mesma parceira neste período).

- O teste DNA-HPV, apesar de ser um exame extremamente preciso e sensível, não é 100%, ou seja, há a possibilidade de que vírus já estivesse presente em pequenas quantidades sem ter sido detectado.
- Além disso, em alguns casos, o vírus pode permanecer inativo ou controlado pelo sistema imunológico por muito tempo (mais de 10 anos) abaixo dos níveis detectáveis pelo exame.



Caso o parceiro opte por realizar o teste DNA-HPV, o resultado negativo não deve ser interpretada como infidelidade ou frustração. Apenas em 12-50% dos casos, ambos são portadores do vírus. Isso porque a regressão e eliminação do HPV pode ocorrer em épocas diferentes e, neste caso, pode já ter acontecido no parceiro.

- Não permita que essa divergência cause transtornos no relacionamento (o portador não deve receber a culpa ou responsabilidade nem deve impedir atividade sexual pelo medo de reinfeção).

GINECOACADEMY

Boas práticas recomendadas:

- Esclarecer que existem tratamentos para as lesões causadas pelo HPV, **mas não para o vírus ou para a infecção do vírus em si**
 - Lembrar que, na maioria dos casos, ou seja, em 90% dos casos, ele será eliminado pelo próprio corpo
 - O que podemos fazer é seguir algumas orientações para garantir que essa eliminação será a mais rápida possível, diminuindo o risco de evolução para lesões preocupantes:
- 

1. Manter o seguimento e rastreamento adequados conforme as orientações médicas

2. Interromper o tabagismo. O cigarro não só reduz a resposta imune e aumenta a replicação viral como também causa dano genético direto, aumentando o risco de progressão para lesões e câncer

3. Manter uma boa saúde genital, investigando e tratando adequadamente infecções vaginais (ex. vaginose bacteriana) e infecções sexualmente transmissíveis (ex. clamídia, gonorreia, herpes, tricomoníase e sífilis)

Já está bem estabelecida na literatura a interação entre o HPV e essas outras infecções, bem como a redução na capacidade de combater o HPV e as lesões causadas por ele quando elas estão presentes ao mesmo tempo que o vírus

GINECOACADEMY

4. Usar consistentemente preservativo para evitar outras infecções sexualmente transmissíveis

5. Controlar ansiedade, depressão e outros distúrbios psiquiátricos. O estresse psicológico modula negativamente a resposta imune e pode interferir na eliminação, regressão ou persistência do HPV

6. Tratar e acompanhar adequadamente condições que reduzem a imunidade, como diabetes, doenças autoimunes, infecção pelo HIV, pacientes transplantadas ou em quimioterapia

GINECOACADEMY



7. A vacinação, apesar de ser profilática e não ser ainda indicada para tratamento da infecção ou para lesões causadas pelo HPV, deve ser recomendada sempre que possível para proteger a paciente e parcerias contra os principais tipos de HPV

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:



Apesar de fatores nutricionais terem potencial papel protetor, atuando em diferentes estágios da história natural da infecção pelo HPV, bem como no desenvolvimento de lesões precursoras e câncer, **ainda não há evidências ou estudos** que comprovem que a suplementação de macro ou micronutrientes (vitaminas, minerais etc), fitoterápicos ou outras medidas nutricionais devam ser indicadas para melhorar a imunidade e ajudar na eliminação do HPV.

MARÇO LILÁS

**Conscientização
e combate
ao câncer de
colo de útero.
Não deixe a
vida terminar
por onde ela
começa!**



**Vaccine-se e faça
exames preventivos
regularmente.**